



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : توابه حلمى محمد على
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : اخرى
رقم البطاقة : 27808222200406 رقم التليفون : 01221153760
العمر (تاريخ الميلاد) : 22-08-1978 المهنة : ربه منزل
العنوان : باها
تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]
قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: توابه حلمى محمد علي National ID: 27808222200406	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient No. : 2459-2024
Patient Name : الأستاذ / نوابه حلمي محمد علي
Sex : Female Age: 47 Y
Financial Cate: جوسفاف روسي - مبادره
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13008247
Request Date : 22-10-2025 13:00
Verification Date : 22-10-2025 13:45
Sample Type : Serum
Test Status : Routine
Analyzers : biolis_hermel

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
Serum Creatinine	1.0	mg/dl	0.6 - 1.2)
Calcium Ionized (Ca++)	1.22	mmol/l	1.10 - 1.30)
Urea	22.6	mg/dl	17.0 - 43.0)

Signature

Dr.\Hassan Fadl

Printing Date : 22/10/2025 13:15:22

Page 1 of 1

Printing By : hermal

فاكس / 25311121

ت/ 25311125 - 25311128

987 كورنيش النيل الملك الصالح

Name: توابه حلمى محمد علي		
MR. : 1483		
Detailed Medical Report		
		السيد
تخية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient was initiated on letrozole (Femara) combined with goserelin acetate (Zoladex) beginning in June 2025, with the most recent Zoladex injection administered on 22 October 2025 and a scheduled due date of 14 January 2026. The last zoledronic acid (Zometa) infusion occurred on 3 November 2024. In December 2025, a screening mammogram of the right breast demonstrated a benign-appearing mass classified as BIRAD 3, and the patient was advised to follow up. The patient continued on letrozole, calcium carbonate with vitamin D (Calcium One Alpha), and goserelin acetate 10.8 mg subcutaneously, with the next goserelin injection planned for 8 April 2026. A pharmacy refill was arranged for the hormonal therapy. The right breast BIRAD 3 finding persisted, and follow-up imaging was recommended. The patient has a history of left-sided breast cancer diagnosed on 17 October 2024, staged pathologically as pT2 N2 (4/18 nodes) invasive ductal carcinoma, grade 2–3, estrogen receptor 7/8 positive, progesterone receptor 8/8 positive, HER2-negative, Ki-67 40 %. Surgical management included breast-conserving surgery (BCS) with a wider excision performed in June 2025, followed by adjuvant taxane-based chemotherapy. Ongoing adjuvant therapy consists of goserelin acetate, letrozole, and a port for continued treatment. In December 2026, a right-breast BIRAD 3 lesion, likely a benign fibroadenoma, was noted, and the patient remains on zoledronic acid and letrozole. The patient continued on adjusted letrozole therapy with supportive care for three months, and goserelin acetate 10.8 mg was administered on 1 July 2026 in preparation for a breast ultrasound evaluation. The patient’s regimen was further continued with goserelin acetate, letrozole, and three months of supportive care, with the next clinic appointment scheduled for 22 September 2026. At the most recent visit, bilateral breast imaging in July 2026 showed BIRAD 2 findings. The patient remains on letrozole, goserelin acetate, and three months of supportive care, with the next clinic appointment planned for 3 November 2026.		
تحريرا في ,		
	التاريخ : 19-09-2026	الوقت :
	نهي سعيد علي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

MDT FORM

19/6/2025 G

Name	توبة حلمي محمد علي	MRN	2459/2024
Age	46 yrs.	ID	01221153760
Menopausal status		Phone	01221153760
NRS SCORE		Marital status	Married
BMI		Family history	
CO morbidity	-	REASON OF MDT	POSTOP

Clinical Data

BX: IDC

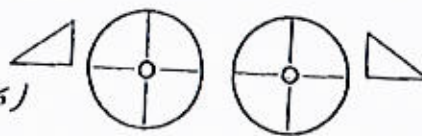
ER: 7/8 PR: 8/8 HER T: 0 KITV: 40

Sonomammography:

- Lt breast UOQ malignant mass (BI-RADS 4)
- Rt breast 9 mm lesion, Lt axillary L.N.

Mets Workup: Lt axillary apt.

R



TNM
2 1 0

Recommendations:

- Rt breast fibroadenoma.
- Lt WLE + ALND → narrow medial margin
- Received ACT, then underwent wider excision.

No residual tumor, No DCIS, Free margins.

MDT OUTCOME & PLAN

Resection site changes & fat necrosis
for PORT
+ AI + Zoladex X 5 yrs
+ Tamoxifen 20mg bid

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name : الأستاذة / نوابه حلمي محمد علي
Patient No. : 27808222200406
Path No. : 2265/24
Sex : Female
Age : 45 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001174
Request Date : 07/07/2024
Verification Date : 16/07/2024
Financial Category : أورام داء السلام - هيلد
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast swelling.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 6/7/2024.

Gross Examination:

- Three grayish white tissue cores up to 2 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II- III.
- Ductal carcinoma in situ: Negative.
- Perineural invasion: Negative.
- Angioinvasion: Negative.
- Microcalcifications: Negative.

Diagnosis:

Left breast swelling, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II- III.
For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 28/07/2024 15:13:44

Page 1 of 1

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Mizr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : / نواله حاسي محمد علي
Patient No. : 27808222200408
Path No. : 3970/24
Sex : Female
Age : 46 Y
Referring Doc :
Request No. : 13009417
Request Date : 17/10/2024
Verification Date : 03/11/2024
Financial Category : -
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis: (Revised)

Left breast, WLE and Axillary lymph nodes:
Invasive duct carcinoma, Grade III with extensive DCIS.
Free other margins. Narrow extra-medial margin.
Positive lymph nodes in (4/18).
Stage: pT2, pN2.

Comment:

The revision of frozen slides of extramedial margin didn't showed the positive focus of DCIS which appears in deep cutting of paraffin section. This indicate very narrow medial margin.

Dr. Rana Fatmy.
Dr. Sagda Elkady.

Signature
Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 03-11-2024 11:19:15

Page 3 of 3

Printing By : Marwa Mohamed Hussien

CAP
ACCREDITED

Room No. (4) - First Floor - Building No. 901 - Nile Concord - Mar El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأب/ملاذ / نوابه حليمي محمد علي
Patient No. : 2780822200406
Path No. : 2265/24
Sex : Female
Age : 45 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13001174
Request Date : 07/07/2024
Verification Date : 28/07/2024
Financial Category : مذكور
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : Mrs. Mayada H

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Left breast mass.

Nature of Specimen:
Tru cut biosy collected at 6/7/2024.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventis) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Moderate nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 40 % nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II-III.
T:
ER: Positive (score 7/8).
PR: Positive (score 8/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 40% of tumor cells.

Verified by :
dnesraa magdy

Printing Date : 28/07/2024 15:13:49

Page 1 of 2

Printed By : Mrs. Mayada Hegozy

Pat. Name: Tawabah Helmi Mohamed	Date : 01/08/2024
Prof :	Pat. ID: 824588

Thank you, Dear Doctor, for Referring The Patient

- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta, IVC and pelvic organs.
- Normal size and excretory capacity of both kidneys.
- IUCD is seen in situ.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

OPINION:

- **Left breast mass pathologically proven IDC "invasive duct carcinoma":-
- Left breast UOQ fairly defined lobulated soft tissue mass lesion with left axillary pathological lymphadenopathy.
- No sizable pulmonary nodules or masses.
- Small right para-spinal cystic lesion.
- Mild hepatomegaly, no sizable hepatic focal lesions.
- Prominent CBD with associated mild central intra-hepatic biliary radicles dilatation, for clinic-laboratory correlation.
- Small right adnexal cyst likely ovarian.
- Small umbilical hernia.

Kind Regards

Dr. Ghada M. Hekal M.D

Lecturer Of Radiology Beni-Suef University

